جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : وهيبه احمد خليل سعدالله
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** التبين **العنوان :** -
رقم البطاقة : 27504152701241 **رقم التليفون :** 01125047493 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-04-1975 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: وهيبه احمد خليل سعدالله
National ID: 27504152701241

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bilateral mammogram and breast ultrasound**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Wahiba Ahmed Khalil Sadallah	Date : 22/10/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 3648/2024	Pat. ID: 93466

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

I Chest:

- *Left breast parenchymal UIQ soft tissue lesion measures about 1.2 x 1.7 cm. Small subcentimetric ipsilateral axillary (level I & II) lymph nodes are seen with preserved fatty hila.*
- Few scattered bilateral mostly subpleural pulmonary nodules, largest is seen at right lower lung lobe measures about 5 mm.
- No pulmonary areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenaution. No sizable focal lesions on non-contrast basis.
- gall bladder Calculus.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicals dilatation.
- Normal non contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenal glands.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- No sizable worrisome osseous lesions.

Opinion:

- **Few scattered bilateral pulmonary nodules ? Sequel of old inflammatory process rather than metastatic ,For follow-up.**
- **No sizable hepatic or osseous deposits on non-contrast basis.**

Dr. Ali Elsisy, MSc.

Dr. Walid Mohamed, M.D.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: وهيبه احمد خليل **MR. :** 9745	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with left breast cancer, clinical stage pT2 N0 M0, and underwent left breast-conserving surgery (BCS) on 25/11/2024. Pathology revealed estrogen receptor (ER) 8/8 positive, progesterone receptor (PR) 8/8 positive, HER2-negative, and Ki-67 5%. The treatment plan includes continuation of adjuvant endocrine therapy with Femara (letrozole) initiated in February 2025, with a planned cessation in September 2025, and the patient is currently free for Zometa (zoledronic acid). The current plan is to maintain the prescribed endocrine therapy schedule and monitor for any disease recurrence.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	dina makram		

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / وهيبه احمد خليل سعدالله	Request No.	: 13002828
Patient No.	: 28504152701241	Request Date	: 23/09/2024
Path No.	: 3589/24	Verification Date	: 16/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast inner central illdefined irregular mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
- Ki67: 5% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:
Left breast inner central illdefined irregular mass, Tru-cut biopsy:
invasive duct carcinoma, Grade II.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 5% of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / وهيبه احمد خليل سعدالله	Request No.	13002828
Patient No.	28504152701241	Request Date	23/09/2024
Path No.	3589/24	Verification Date	16/10/2024
Sex	Female	Financial Category	اوزام دار السلام - نفقة الدولة
Age	49 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ghonaim.
Dr. Toka Medhat.

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- N'c Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / وهيبه احمد خليل	Request No.	: 13009959
Patient No.	: 27504152701241	Request Date	: 25/11/2024
Path No.	: 4622/24	Verification Date	: 17/12/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis:
Left breast cancer, Up-Front, BCS & SLNs biopsies:
Invasive duct carcinoma, Grade II.
Free Resection Margins
Free skin.
Free SNLs (0/5).
Stage: pT2, pN0

Signature
Prof.Dr.Gamal Abdelatty
Dr.Menna Nabil

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : وفيه كامل سعد الله
Sex: Female
3- Medical number: 83238864
OM Med : 3643-2024

2-ID number:
Patient Age : 50 Y

Family history		Phone	01125047493	BMI		REASON OF MDT	
marital status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	09/01/2024
Co morbidity	dnt,htn	Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :
lt inner central mass 22x21 mm
non specific axillary LN

Mets Workup :
cap:free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KiG7
IDC	S/S	S/S	-ve		5

T	N	M
2 (2.2cm)	0	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
FOR LT BCS+SLNB:IDC GII
free margins , skin,LN 0/5

MDT OUTCOME & PLAN

1- adjuvant aromatase inhibitor
2- port
3- zometa/6 months

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

PATIENT NAME: Wahiba Ahmed KHALIL SAAD ALLAA
GENDER: Female
DATE : 20-Nov-2024 11:30 AM

PATIENT ID: 20224014075
AGE: 49 y
ORDER: Z137785,Z137918

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY WITH COMPLMENTARY US

INDICATION:
- left breast mass

TECHNIQUE:
- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV non-ionic contrast medium infusion

REPORT:
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed minimal symmetrical back ground parenchymal enhancement.
- Left breast upper inner quadrant irregular mass showing intense heterogenous mass enhancement with fine spiculation measured 2.2 X2.7cm, being 9.9 cm from the nipple, complemntary US reveals 9 o'clock para-midline irregular hypoechoic mass measuring 2.2X1.7 cm surrounded by desmoplastic reaction, about 0.5 cm depth from the skin
- No right breast mass or non mass enhancement.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific bilateral axillary lymph nodes.
- No left infra or supraclavicular lymph nodes.

OPINION:
-left breast UIQ enhancing malignant mass lesion.(BIRADS 5).
- No right breast pathological mass or non mass enahncement (BIRADS 2)

Reported By,

Dr. Yomna Tarek, MSc **20-Nov-2024 12:09 PM**

www.Baheya.org 16602
مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

مـــــحة والسكـــان
كز الطبية المتخصصة
ى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Wahiba Ahmed Khalil Sadallah	Date : 24/11/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 3648/2024	Pat. ID: 93466

Targeted ultrasound on left axilla

Indication:

- Patient with pathologically proven left breast carcinoma.

Report:

- Multiple enlarged axillary LNS with preserved fatty hilum likely non specific
- Free supra and infra clavicular regions.

Signature Dr. Walaa Abdelazez

24/11/2024 4:20 PM

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECIION SUPPORT

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :23-9-2024 جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) وهيبه احمد خليل بطاقة رقم 27504152701241

تليفون رقم: 0125047493

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنة مسنولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه :23-9-2024

الموظف المختص

اعتماد محمد

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 1458940

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient Name: Wahiba Ahmed Khalil Sadallah	Date : 27/09/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 50 Year(s)
Medical ID: 3648/2024	Pat. ID: 93466

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY

Indication: Follow up after left conservative breast surgery.

- **Breast density:** Heterogeneously dense. *Breast density matches ACR C.*
- **Mild left breast diffuse skin thickening reaching 5 mm.**
- No detected suspicious mass density, architectural distortion or pathological micro-calcification.
- Bilateral scattered benign calcifications with lucent centers.
- Normal right breast skin and nipple.

By complementary breast ultrasound:

- Homogenous (predominantly fatty) back ground parenchymal echo-texture.
- **Clear left operative bed, no detected tumor residue or recurrence, however mild inflammation in the form of echogenic fat planes and skin thickening**
- **No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts.**
- No detected dilated retro-areolar ducts.
- No detected significant axillary LNs.

CONCLUSION:

- **Few right breast benign calcifictaions (BI-RADS 2 category) .**
- **Left breast clear CBS bed with post operative changes as detailed, for follow up (BI-RADS 3 category) .**

Yara Mohamed, MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]